

表 9 VA-ECMO 临床启动快速筛查评估表(2)

姓名		性别	☐ 男 ☐ 女
住院号		评估时间	20__年__月__日 __时__分
启动场景	☐ 普通 VA ☐ ECPR(心跳骤停) ☐ 术中/术后脱机困难	年龄	岁
第四步：相对禁忌与风险评估(存在以下情况时不绝对排除 VA-ECMO，但需多学科讨论权衡利弊)			
相对禁忌	需评估的内容		
重度主动脉瓣反流（AI）	LV 减压策略是否可行？ (IABP/Impella/外科引流) →如可减压则非绝对禁忌		
高龄（> 75 岁）	综合评估衰弱指数、功能状态、合并症,生物学年龄>日历年龄		
严重外周血管疾病（主动脉/股动脉广泛钙化、狭窄、闭塞）	能否建立替代通路？（腋动脉/中心插管）→血管外科评估		
严重肝功能不全（Child-Pugh B 或 C）	基础肝病者 ECMO 预后极差，化疗相关可逆性肝损则不同		
长期机械通气导致不可逆的严重肺纤维化	即使心脏恢复，肺功能可否维持长期生存？		
严重凝血功能障碍（非急性、可纠正）	先纠正（维生素 K/PCC/血浆），重评		
SAVE 评分辅助决策[已完成 SAVE 评分（参见附件 7），SAVE 总分 = ____ 分，预测生存率 ≈ ____%]			
SAVE 风险等级	决策建议		
低风险 / 中低风险	积极启动		
中风险	可启动，与家属充分沟通		
中高风险	MDT 讨论 + 家属详细沟通		
高风险（≤ -10）	除非有特殊可逆因素或移植桥接，一般不建议		
评估结论与决策			
结论	判定条件		
立即启动 VA-ECMO	满足适应症 + 无绝对禁忌 + 相对禁忌可控	☐	
立即启动 ECPR	心跳骤停+ CPR ≥ 15 min +无绝对禁忌→启动补充 2 流程	☐	
MDT 紧急会诊后再决定	存在多项相对禁忌或血管条件极差，或 SAVE 高风险但仍有可逆因素	☐	
暂不启动/放弃启动	存在绝对禁忌，或 SAVE 高风险且不可逆	☐	
评估医生签名： _____ 上级医师签名： _____			

依据: ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIJOJ)+SAVE 评分(Schmidt et al.2015)+ECPR 相关指南(AHA 2025) 用

途：VA-ECMO 启动前的快速四步评估，5-10 分钟内完成

配套使用：表 15（SAVE 评分）+ 表 12-14（ECPR 专项流程）

ECPR 场景请 (1) 跳过第二步 (2) 2 分钟内完成第一步绝对禁忌筛查 (3) 立即启动表 12~14 流程。不要在评估表上耽误时间。